

Aportes del Autocuidado al Bienestar Psicológico en personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados de tres Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Lima Metropolitana¹

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Investigador Principal

Carlos Alberto Arenas Iparraguirre ^{1,2}

Co-Investigadora

Tanya Magali Taype Castillo ^{1,2}

Equipo de Investigación

Guillermo Almeida-Huanca ^{1,2}

Ana Laura Silva-Cavero ^{1,2}

Benjamin R. Bazan-Joaquin. ^{1,2}

Diana Arenas ²

Colaborador invitado

José Luis Mireles-Espinoza²

Filiaciones Institucionales:

¹ Grupo de Investigación Psicología Social y Desarrollo Humano (PSOCYDEH)

² Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Financiado por:

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(ID: A24181271)

Fecha: abril 03, 2024 - Versión 01¹

¹ Contributions of self-care to Psychological Well-being among users of the Continuity of Care Programme in three Continuity of Care Programme in three Community Mental Health Centres (CSMCs) in Lima Metropolitana

1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos de salud mental presentan alta prevalencia y generan carga de discapacidad en la sociedad, pese a ello, en los países de América Latina sólo existe un 2% de inversión del presupuesto público (World Health Organization, 2021). En Perú, los trastornos son la principal causa de carga de enfermedad (12,7%) (Ministerio de Salud, 2018). Para reducir esta brecha, inició la reforma de atención en salud mental, cuya implementación ha propiciado 248 Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) en todo el país (MINSA, 2023). Cada CSMC, cuenta con un Programa de Continuidad de Cuidados (PCC). El cual tiene como objetivo lograr el máximo nivel de autonomía en las personas usuarias de los CSMC a través de su recuperación funcional, y con ello, la reinserción social en el ámbito familiar, comunitario y laboral (MINSA, 2017).

La evidencia demuestra la eficacia de estos programas en países de altos ingresos; sin embargo, en países de ingresos medios y bajos aún es limitada, debido a tareas pendientes como el desarrollo de marcos normativos, mejoras en la gestión de recursos y el fortalecimiento de la capacitación y acompañamiento (Diez-Canseco et al., 2020).

En cuanto a la participación de las personas usuarias de servicios en los esfuerzos por ampliar el acceso a la atención de salud mental, en países como Etiopía se realizó un estudio cualitativo orientado a explorar las barreras y facilitadores de la participación en las zonas rurales, entrevistando a personas usuarias, cuidadores, jefes de centros de atención primaria, y formuladores de políticas, planificadores y desarrolladores de servicios. Obteniendo que los grupos estudiados coincidieron en apoyar la participación de las personas usuarias, ya que se identificaron beneficios al incrementar la idoneidad y calidad de estos; así como mayor protección contra el maltrato y promoción del respeto por las personas usuarias. Así también, se halló que una de las principales barreras generalizadas era el estigma dentro del sistema de salud, la comunidad y los individuos (Abayneh et al., 2017).

En ese sentido, desde otro estudio orientado a abordar los estigmas hacia la salud mental, en un programa de intervención en brechas en la salud mental dirigido a trabajadores de atención primaria de la salud en Nepal, se capacitó a los usuarios de servicios como co-facilitadores para, a su vez, la capacitación de reducción de estigmas en los proveedores de salud. Se obtuvo entre sus hallazgos, como parte de los beneficios percibidos por parte de los cuidadores, una reducción de la carga del cuidador, además del aprendizaje de nuevas habilidades y oportunidades para desarrollar grupos de apoyo, reflexionando finalmente en cómo el compromiso de participación con las familias permite una mayor identificación de los factores motivacionales y las barreras que impactan en el desempeño óptimo del programa (Rai et al., 2018).

Por otro lado, al explorar las estrategias de autocuidados en agentes comunitarios de la salud, según un estudio realizado en un distrito de Chíncha, Perú, se identificaron estrategias en el recurrir a las redes de soporte, así mismo, en creencias y tradiciones culturales propias de la localidad, entre ellas las creencias y rituales de la religión católica. Así también, si bien poseen conductas dirigidas a prevenir riesgos según las recomendaciones asimiladas del sector salud, presentaron hábitos que perjudican su salud a largo plazo de forma crónica (Salas, 2016).

Tomando dichos referentes, la investigación en programas de salud mental comunitaria implica la participación de los tres agentes: personas usuarias, cuidadores familiares, y

proveedores de salud, clave para aproximarse al conocimiento de cuáles estrategias de autocuidado emplean las personas quienes participan como usuarios de los PCC de CSMC, y cómo interviene ello en la conservación o el fortalecimiento de su bienestar psicológico. Por ello, el objetivo del estudio es conocer las prácticas del autocuidado al bienestar psicológico en personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados de tres Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Lima Metropolitana.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Conocer los procesos de autocuidado en el bienestar psicológico de las personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados (PCC) de tres Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Lima Metropolitana.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Conocer las percepciones del autocuidado del bienestar psicológico de las personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados (PCC) de tres Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Lima Metropolitana.
- II. Identificar las prácticas de autocuidado de las personas usuarias del PCC de tres CSMC de Lima Metropolitana.
- III. Identificar las barreras y facilitadores que influyen en la práctica del autocuidado por parte de las personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados de los CSMC de Lima Metropolitana.
- IV. Conocer las percepciones de los cuidadores y del personal de salud sobre los procesos de autocuidado del bienestar psicológico de las personas usuarias del Programa de Continuidad de Cuidados de tres Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) de Lima Metropolitana.

3. METODOLOGÍA

3.1. MARCO CONCEPTUAL

El bienestar psicológico es considerado como lo subjetivo de la calidad de vida de las personas (Fernández et al., 2014), la cual contiene aspectos como el nivel de salud, de educación, el acceso al empleo y a servicios básicos (agua potable, saneamiento, luz, combustibles para cocinar, internet) y la tenencia de bienes y riquezas (Alkire et al., 2015).

Dentro del concepto bienestar psicológico se comprende la suma de los aspectos cognitivos, conductuales y sociales que dotan a las personas de habilidades para obtener una calidad de vida adecuada y mantener una salud mental que le permitan relacionarse de manera significativa con los demás y con su contexto inmediato (Ryff, 1995).

Las teorías acerca del bienestar psicológico pueden agruparse en dos grandes conjuntos: (a) *teorías hedonistas*, que se centraron en el estudio del bienestar subjetivo, por medio de conceptos como: felicidad, satisfacción con la vida y afectos positivos (y negativos), para evaluar principalmente el grado en que las personas están satisfechas con su vida; (b) *teorías eudamónicas*, que se han enfocado en el análisis del bienestar psicológico, abordando aspectos

como el crecimiento y desarrollo personal, los estilos y estrategias para afrontar retos vitales y el esfuerzo por conseguir metas individuales (Blanco y Díaz, 2005; Díaz et al., 2006). Dentro de ésta última tradición se encuentra el modelo multidimensional del bienestar psicológico de Carol Ryff, el cual será utilizado en el presente estudio.

El modelo de Ryff propone que el bienestar psicológico puede ser estructurado en 6 dimensiones:

- *Autonomía*, que implica la capacidad de resistir presiones sociales, pensar y actuar acorde a estándares personales y evaluarse a uno mismo en base a tales estándares.
- *Dominio del entorno*, que consiste en la habilidad de controlar ciertos elementos externos, utilizar efectivamente las oportunidades y poder crear contextos que estén acorde a los valores y necesidades personales.
- *Crecimiento personal*, que implica un sentimiento continuo de desarrollo, la apertura a nuevas experiencias y el desarrollo del autoconocimiento y la efectividad de sus comportamientos a lo largo del tiempo.
- *Relación positiva con otros*, que consiste en la capacidad de tener empatía por los otros, sentir calidez y satisfacción de las relaciones con los demás y el poder brindar afecto y tener intimidad con las personas.
- *Propósito en la vida*, que implica el tener metas definidas en la vida y un sentido de la vida presente y pasada.
- *Autoaceptación*, que consiste en el reconocimiento y aceptación de los aspectos positivos y negativos propios de la persona y poseer una actitud positiva sobre uno mismo (Ryff y Keyes, 1995).

El primer componente en mención, tomado para este estudio en relación a los autocuidados del bienestar psicológico, parte del derecho de las personas a desenvolverse con independencia y de discernir respecto a su toma de decisiones diarias en diversos niveles de complejidad. Con ello, se define al concepto de autonomía como la capacidad de planificar y ejecutar decisiones, siguiendo un argumento moral personal, asunción de la responsabilidad, con acompañamiento y/o apoyo, de ser necesario, para la ejecución de la decisión tomada. Esta capacidad comprende el análisis de situaciones, la identificación de alternativas y la ejecución última de acciones que demuestren el desempeño autónomo de las persona (Huenchuan y Rodríguez, 2014), sea en actividades básicas de la vida diaria (asearse, vestirse, alimentarse), instrumentales (tareas en el hogar y en la comunidad), y avanzadas (participación social).

Ahora bien, con respecto al *autocuidado*, este se entiende como una serie de acciones que realiza una persona con el fin de cuidar de sí misma para tener un buen funcionamiento (Cavero, 2018). Por otro lado, el *autocuidado del bienestar psicológico* es definido en este estudio como las prácticas y estrategias que una persona emplea para mantener y mejorar su salud psicológica y bienestar general, permitiendo a las personas enfrentar de manera resiliente las adversidades que enfrenta y aprovechar las oportunidades que se le presentan para su crecimiento personal y social (Cavero, 2018; Gonzáles et al., 2013; Ryff, 1989).

En ese sentido, para Gonzáles et al. (2013), el “manejar positivamente la enfermedad” implica el ser proactivo realizando actividades para atenuar y superar los problemas físicos (por ejemplo, fatiga, pérdida de fuerza y resistencia, etc.) y psicológicos (estrés, ansiedad, entre otros) que vienen ligados a las enfermedades crónicas y los trastornos mentales. De tal manera,

es como la persona experimenta que toma el control de su salud y de su vida, llegando a alcanzar las metas que se propone y disfrutando de la vida más plenamente.

Algunos de los aspectos que implican el ser una persona proactiva en el manejo de su enfermedad-trastorno es: primero, conocer más acerca de su condición diagnóstica (las causas, síntomas, tratamientos y distintas consecuencias que implica) y segundo, llevar un registro de los cambios que se están dando a nivel de salud a causa de la condición diagnóstica (González et al., 2013).

Las tres habilidades para manejar positivamente el proceso de salud-enfermedad son:

- *Habilidades para manejar la enfermedad*: implementando los cambios que conllevan la condición diagnosticada (consumo de medicación, controles periódicos con el personal de salud, cambios en los hábitos alimenticios, deportes o ejercicios físicos, etc.)
- *Habilidades necesarias para continuar con la vida normal*: contempla las estrategias para continuar fortaleciendo las relaciones familiares, mejorando los vínculos con amistades, seguir laborando y participando de la comunidad.
- *Habilidades necesarias para manejar las emociones*: implican las estrategias que se emplean para reconocer las emociones y sentimientos personales y cómo encauzarlas para que no afecten negativamente (González et al., 2013).

3.2. PRIMER COMPONENTE: ESTUDIO CUALITATIVO

3.2.1. DISEÑO

El estudio se llevará a cabo desde el enfoque cualitativo. El diseño de investigación es fenomenológico (Creswell, 2007).

3.2.2. PARTICIPANTES

3.2.2.1. ÁMBITOS DE ESTUDIO

El estudio se desarrollará en 3 CSMC de tres DIRIS en Lima Metropolitana (DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Sur y DIRIS Lima Este). De acuerdo a las características sociodemográficas y de vulnerabilidad de la salud mental de la población atendida en estas tres zonas. El Programa de Continuidad de Cuidados (PCC) es un servicio de atención continua, intensiva y personalizada que recibe la usuaria y/o su cuidador (a) para garantizar la calidad de cuidados, favoreciendo el bienestar y el funcionamiento en respuesta a sus necesidades, por lo que representa una excelente oportunidad para contribuir desde la investigación en la generación de evidencias que optimicen su implementación en los CSMC del país.

Nombre del Centro de Salud Mental comunitaria seleccionada, perteneciente a la DIRIS Lima Centro: CSMC La Victoria y CSMC Javier Mariátegui Chiappe (ex – Zarate)

3.2.2.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO

El muestreo será de tipo intencionado, y la estrategia de muestreo será por conveniencia, la cual se realiza según la disponibilidad de los posibles informantes (Mejía, 2000), debido a que se puede aplicar en grupos pequeños para cada uno de los actores mencionados anteriormente, a fin de conocer sus percepciones y/o prácticas (ésta última para el caso de las personas usuarias). Por ello, se trabajará con 6 perfiles y la capacidad de los establecimientos para incorporar estrategias para promover el autocuidado en usuarios.

La aproximación a los trabajadores de salud, usuarios y familiares será a partir de los CSMC incluidos en el estudio. Además, se complementará con la técnica de bola de nieve, en donde los participantes iniciales nos ayudarán a identificar y facilitar el contacto con nuevos posibles entrevistados que cumplan con los criterios de inclusión. Esta estrategia de reclutamiento ha sido utilizada previamente en los CSMC como parte de otros estudios, obteniendo buenos resultados.

Aquellas personas que cumplan con estos criterios y acepten participar, serán contactados por el equipo de investigación para extenderles una invitación formal. En el caso de los jefes del CSMC, se les contactará directamente a través de una carta de invitación.

Se espera contar con al menos 36 participantes. Se realizarán un máximo de 36 entrevistas, divididas entre 6 perfiles de participantes, tal como se detalla a continuación:

Perfil	Total por CSMC	Total
Usuarios del CSMC	5	15
Cuidadores de usuarios de los CSMC	3	9
Equipo Interdisciplinario ²	3	9
Gestor(a) de cuidados ³	1	3
Coordinador del PCC ⁴	1	1
Jefes del CSMC	1	1
Total	17	36

Nota:

¹ Los colores utilizados tienen el propósito de brindar una ayuda visual al lector para revisar la tabla de características de los participantes.

² El equipo interdisciplinario es formado por profesionales de salud mental (psiquiatra, enfermero(a), médico(a) familiar, psicólogo(a), terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, médico cirujano de la persona) encargados del cuidado de la usuaria

³ Los gestores son profesionales encargados del equipo interdisciplinarios

⁴ El coordinador de la PCC suelen ser enfermeros con especialidad en salud mental

Todos los participantes del estudio tendrán 18 años o más, que hayan brindado su consentimiento para aceptar participar en el estudio

y que vivan en Lima metropolitana o alguno de sus distritos durante la recopilación de los datos. Se excluirá a cualquier participante que no esté en capacidad de decidir voluntariamente participar en el estudio y de poder participar en una entrevista. La capacidad para participar en el estudio será confirmada por los investigadores. El equipo de investigadores cuenta con experiencia previa trabajando con personas con trastornos mentales y contarán con la formación ética necesaria para trabajar con poblaciones vulnerables. Algunos criterios adicionales son los siguientes:

En el caso de las **personas usuarias**, se incluirá a aquellas que sean continuadores de los servicios; es decir aquellos que hayan recibido al menos 3 veces durante los últimos 6 meses, que no cuenten con un diagnóstico que limite sus funciones cognitivas o de orientación en espacio-tiempo y que estén en capacidad de decidir voluntariamente su participación. Se excluirán a aquellos que se encuentren en una etapa crítica de su condición de salud mental durante el reclutamiento. Se buscará diversificar por condiciones de salud y género. Durante las entrevistas, los usuarios tendrán la oportunidad de ser acompañados por un familiar o cuidador.

Para **cuidadores**, se incluirá a aquellas que realicen la labor de acompañamiento y cuidados de alguno de los usuarios de los CMSC seleccionados y conocer sobre la atención que reciben. Además, se tomará en cuenta un tiempo de 6 meses.

Respecto al **equipo interdisciplinario**, se incluirá a quienes realicen intervenciones en PCC, participen en el proceso de recuperación y/o participen activamente en las discusiones de la situación de usuarios del servicio. Además, deben encontrarse laborando actualmente en el establecimiento.

Para **gestores de cuidados**, serán incluidos aquellos que realicen evaluación inicial, seguimiento y altas en el PCC, articule con familia y redes comunitarias de salud mental y mantenga un contacto continuo con la persona usuaria y/o su cuidador (a).

Para **coordinador de cuidados**, se incluirá a quienes gestionen el diálogo, intercambio de opiniones y toma de decisiones sobre estrategias y acciones que mejoren el servicio, asignen un gestor a cada persona usuaria, supervise el cumplimiento de las actividades de los gestores de cuidados y coordine con actores sociales, sanitarios y comunitarios para reuniones de articulación entre redes comunitarias en un período mínimo de 6 meses.

En el caso de **jefes del CSMC** serán incluidos aquellos que brinden asistencia técnica al equipo interdisciplinario y realicen funciones dentro del PCC en un periodo mínimo de 6 meses.

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para realizar la recopilación de datos se utilizarán: (a) Una ficha de datos que recoja información sociodemográfica de cada participante, (b) 2 guías de entrevista semiestructurada diseñada (para el trabajo con las personas usuarias y cuidadores), (c) guías de entrevistas para grupos focales para funcionarios del programa. Cada uno de los instrumentos elaborados será previamente diseñado con relación a su objetivo específico de investigación correspondiente. Además, serán validadas mediante el criterio de jueces expertos y la aplicación piloto de una entrevista a uno de los actores correspondientes.

Las dimensiones a explorar en la guía de entrevista comprenden la autoaceptación del proceso de salud que atraviesa, habilidades sociales en el manejo de situaciones conflictivas, autonomía en el proceso de toma de decisiones, dominio del entorno y empoderamiento en el autocuidado.

3.2.4. PROCEDIMIENTOS

El muestreo será de tipo intencionado, y la estrategia de muestreo será por conveniencia, la cual se realiza según la disponibilidad de los posibles encuestados (Mejía, 2000), debido a que se puede aplicar en grupos pequeños para cada uno de los actores mencionados anteriormente, a fin de conocer sus percepciones y/o prácticas (ésta última para el caso de las personas usuarias). Por ello, se trabajará con 6 perfiles y la capacidad de los establecimientos para incorporar estrategias para promover el autocuidado en usuarios.

La aproximación a los trabajadores de salud, usuarios y familiares será a partir de los CSMC incluidos en el estudio, en el que los participantes nos ayudarán a contactar a nuevos posibles entrevistados y participantes a observar que cumplan con los criterios de inclusión. Aquellos que estén de acuerdo con participar, serán contactados por el equipo de investigación y se les invitará a participar. En el caso de los **jefes del CSMC**, se les contactará directamente a través de una carta de invitación.

Las entrevistas se realizan idealmente de manera presencial y se realizarán de forma remota si las condiciones lo requieren y/o así lo deciden los participantes. De ser presencial, se coordinará con los CSMC para contar con un espacio en el cual podamos realizar la entrevista, tal como se ha realizado en estudios previos a la pandemia. De ser virtual, las entrevistas se harían a través de la plataforma Zoom/Meet según las condiciones de los participantes.

Se estima que las entrevistas durarán aproximadamente **60 minutos** con la mayoría de los participantes a excepción de los **jefes de CSMC**, con quienes, podrían ser más extensas debido a la gran cantidad de información que poseen sobre la experiencia de los CSMC.

Para todos los encuentros presenciales, **el equipo de investigación usará un identificador para presentarse al CSMC y la carta de presentación de parte del VRIP UNMSM**. Además, se asegurará que el ambiente de entrevista esté ventilado y libre de estímulos que interrumpan la recopilación de datos.

3.2.5. ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de datos, se grabará y transcribirán los registros de audio a documentos de Microsoft Word 2022, previo consentimiento de los participantes. Los nombres de los participantes no serán mencionados en las grabaciones y se utilizarán pseudónimos para proteger su identidad. Posteriormente, serán exportados al complemento del software especializado en análisis de datos cualitativos ATLAS.ti 23. El plan de análisis se basa en el análisis temático de Braun y Clarke (2006), empezando por: (a) la familiarización de la data a través de la lectura y transcripción, (b) generación de códigos iniciales, (c) búsqueda de temas a partir de los códigos analizados, (d) revisión de los temas mediante un mapa semántico, (e) definición y nombramiento de los temas y (f) elaboración del reporte final.

Para la construcción de significados, se utilizarán los criterios de saturación utilizados de Miles et al., (2013): a) frecuencia de categorías: a mayor repetición del código, este adopta mayor importancia; b) densidad teórica: aquellas categorías que se vinculan a otras; c) representatividad: códigos que aparecen al menos una vez en cada documento.

Con respecto a los criterios de rigurosidad se seguirán los criterios de confirmabilidad y transformatividad. El primero, minimizará sesgos y tendencias del investigador al realizar la triangulación de los datos, la grabación de los audios, así como la explicitación de la lógica para la interpretación de los datos; mientras que el segundo, está situado en proporcionar una visión de equidad, escuchando a grupos en condiciones de vulnerabilidad y al reconocimiento de la posición del investigador con relación a los resultados obtenidos (Mertens, 2015).

3.3. SEGUNDO COMPONENTE: SESIONES DE CO-DISEÑO

El segundo componente consiste en reuniones participativas con distintos actores clave para el co-diseño de una guía de autocuidado para las personas usuarias del PCC. Esto responde a la indagación colectiva autorreflexiva de los actores principales con la finalidad de mejorar alguna condición o situación actual (Lune y Berg, 2017); a su vez que nos permitirá conocer y valorar los alcances obtenidos en los programas, actividades y guías implicando a la comunidad en su propia transformación y mejora.

3.3.1. SESIONES DE CO-DISEÑO

Se realizaron reuniones con actores de distintos perfiles para poder diseñar de manera colaborativa la guía de autocuidado para los usuarios de los servicios del PCC en los CSMC seleccionados.

Para estos espacios se contará con actores de los siguientes perfiles:

ACTOR SOCIAL	COMENTARIO ADICIONAL	CANT.
--------------	----------------------	-------

Usuario de los CSMC	El participante ya accedió a las entrevistas previamente	9
Cuidadores de los usuarios	Los cuidadores al menos tienen conocimiento del estudio	3
Profesionales de salud de los CSMC	Los profesionales al menos tienen conocimiento del estudio	6

Las sesiones tendrán una duración de 90 minutos cada una, contemplando un espacio de recepción y uno de receso. En cuanto a la metodología de las sesiones esta será principalmente participativa, ya que facilitará la elaboración de recursos los cuales servirán de insumo para la guía de autocuidado. Los esquemas de sesiones propuestos se describen en anexos.

Estas reuniones se darán en la modalidad de talleres participativos, formulados bajo el siguiente objetivo general: Distinguir las prácticas de autocuidado según a qué áreas del bienestar psicológico impactan para que el personal de salud lo considere en la reformulación y/o actualización de los protocolos de atención del PCC de los CSMC. Además de los siguientes objetivos específicos: (i) Identificar y distinguir las prácticas de autocuidado en usuarios de los servicios de salud mental y cómo impactan en su bienestar psicológico, (ii) Sistematizar las recomendaciones para el autocuidado en salud mental priorizando los contenidos propuestos por las personas usuarias de los servicios.

Se llevarán a cabo tres sesiones para el cumplimiento de los objetivos planteados. Las primeras dos sesiones tendrán como público objetivo a los usuarios y cuidadores de los servicios de PCC; mientras que en la tercera sesión, se incluirá la participación del personal de salud, para un proceso de retroalimentación de los contenidos priorizados por las personas usuarias y el equipo de investigación. En la primera sesión, se compartirán los hallazgos obtenidos al grupo y se discutirá el impacto del autocuidado en el bienestar psicológico. En las siguientes reuniones, se solicitarán propuestas de contenidos y se discutirán entre las personas participantes para priorizar los contenidos finales a considerar en la guía de autocuidados.

Al finalizar de estas sesiones, se contará con una guía de autocuidados que valore las recomendaciones de las personas usuarias del PCC de los CSMC seleccionados.

4. GESTIÓN DE CALIDAD DE DATOS

4.1. TRATAMIENTO DE DATOS Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS

La información recopilada será registrada a través de grabaciones de audio y Desde el inicio de la recopilación de los datos hasta el cierre, los investigadores organizarán los archivos de los testimonios obtenidos de los participantes en carpetas de la nube. Se incluirá un proceso de revisión que incluye el seguimiento y registro de los datos personales de los participantes. Los investigadores responsables del contacto y programación de entrevistas serán los únicos que tendrán acceso.

4.2. PROTECCIÓN DE DATOS

Los investigadores responsables del análisis tendrán acceso a la data. Cualquier transferencia de datos a otros participantes será agregada, desidentificada y cumplirá el protocolo de transferencia segura de datos establecido por el equipo de investigación. Las bases de datos estarán encriptadas y protegidas por contraseña. La base de datos estará disponible en la nube del proyecto y con acceso al usuario del equipo. Todos los datos permanecerán bajo custodia del grupo de investigación y solicitud de los integrantes del equipo investigador. La retención es de 5 años, tiempo suficiente para garantizar la publicación de los resultados y otros productos insumos.

5. PAUTAS ÉTICAS

5.1. ÉTICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

La participación en este estudio será totalmente voluntaria y no se obligará a ninguna persona a participar. El consentimiento contará con una breve descripción del estudio y sus objetivos, aclarando que la persona es libre de participar y de poder poner fin a la entrevista en cualquier momento. Las personas interesadas y dispuestas a participar recibirán una copia de la declaración de consentimiento.

5.2. RIESGOS Y BENEFICIOS

No existe un beneficio directo para las personas participantes, pero sí se prevé beneficios sociales e individuales indirectos como la provisión de una guía práctica de pautas de autocuidado.

5.3. CONFIDENCIALIDAD DE LA PARTICIPANTE

Se mantendrá la confidencialidad de los datos de las participantes y la divulgación de su información personal se realizará previo consentimiento. El protocolo, el consentimiento informado y el instrumento de recolección de datos para esta fase del estudio serán revisados y aprobados por un equipo técnico de la Facultad de Psicología UNMSM.

ANEXOS

Matrices de sesiones propuestas para la segunda fase del estudio

Sesión 1		
Objetivo: Identificar y distinguir las prácticas de autocuidado en usuarios de los servicios de salud mental y cómo impactan en su bienestar psicológico		
Participantes: personas usuarias del PCC y sus cuidadores		
Momento	Actividades	Tiempo

Recepción	- Registro de asistencia - Entrega de ficha con pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	10'
Presentación	- Presentación de la investigación (Solo el nombre y su pertenencia a la UNMSM) - Presentación del equipo facilitador - Presentación de los participantes - Explicación de las pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	10'
Socialización de avances	- Presentación del proyecto - Presentación de avances del proyecto - Objetivos de la sesión	10'
Desarrollo	- Recopilación de información priorizada por las personas en cuanto a las siguientes prácticas: * Planificación personal * Agencia y Redes de apoyo * Manejo de síntomas consecuentes al malestar psicológico * Control de emociones * Manejo de pensamientos negativos * Control de la ira * Estrategias para la resolución de conflictos * Estrategias para toma de decisiones <i>Nota:</i> por ahora se están proyectando las categorías, estas deberán salir desde los resultados de la primera etapa	30'
Plenaria	Se fomentará el diálogo entre las personas participantes a fin de vincular la información identificada con el entendimiento sobre cómo el autocuidado impacta en su bienestar psicológico.	10'
Receso	- Entrega de refrigerios <i>Nota:</i> este espacio se dará durante el desarrollo de la sesión	10'
Cierre	- Reflexiones por parte de los participantes - Socialización de la agenda de la siguiente sesión - Invitación a la siguiente sesión	10'

Sesión 2 Objetivo: Sistematizar las recomendaciones para el autocuidado en salud mental de las personas usuarias de los servicios
Participantes: personas usuarias del PCC y sus cuidadores

Momento	Actividades	Tiempo
Recepción	- Registro de asistencia - Entrega de ficha con pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	10'
Presentación	- Presentación de la investigación (Solo el nombre y su pertenencia a la UNMSM) - Presentación del equipo facilitador - Presentación de los participantes - Explicación de las pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	5'
Socialización de avances	- Presentación del proyecto - Objetivos de la sesión	5'
Desarrollo	- Recopilación de información en cuanto a las siguientes recomendaciones: * Planificación personal * Agencia y Redes de apoyo * Manejo de síntomas consecuentes al malestar psicológico * Control de emociones * Manejo de pensamientos negativos * Control de la ira * Estrategias para la resolución de conflictos * Estrategias para toma de decisiones <i>Nota:</i> por ahora se están proyectando las categorías, estas deberán salir desde los resultados de la primera etapa	50'
Plenaria		
Receso	- Entrega de refrigerios <i>Nota:</i> este espacio se dará durante el desarrollo de la sesión	10'
Cierre	- Reflexiones por parte de los participantes - Socialización de la agenda de la siguiente sesión - Invitación a la siguiente sesión	10'

Sesión 3 Objetivo: Sistematizar las recomendaciones para el autocuidado en salud mental para usuario de los servicios		
Participantes: personas usuarias del PCC, cuidadores y profesionales de salud de los CSMC		
Momento	Actividades	Tiempo

Recepción	- Registro de asistencia - Entrega de ficha con pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	10'
Presentación	- Presentación de la investigación (Solo el nombre y su pertenencia a la UNMSM) - Presentación del equipo facilitador - Presentación de los participantes - Explicación de las pautas básicas para el desarrollo adecuado de la sesión	5'
Socialización de avances	- Presentación del proyecto - Objetivos de la sesión	5'
Desarrollo	- Elaboración de una ruta personal para el autocuidado del bienestar psicológico con base a los insumos trabajados en la sesión anterior	50'
Receso	- Entrega de refrigerios <i>Nota:</i> este espacio se dará durante el desarrollo de la sesión	10'
Cierre	- Reflexiones por parte de los participantes - Agradecimientos - Despedida	10'

6. Cronograma de actividades

Link del cronograma en Excel: [Cronograma del proyecto de investigación](#)

7. REFERENCIAS

- Abayneh S., Lempp H., Alem A., Alemayehu D., Eshetu T., Lund C., Semrau M., Thornicroft G., Hanlon C. Service user involvement in mental health system strengthening in a rural African setting: *Qualitative study*. *BMC Psychiatry*. 2017;17:187. doi: 10.1186/s12888-017-1352-9
- Alkire, S., Foster, J., Seth, S. Santos, M., Roche, J. y Ballón, P. (2015). *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*. Oxford University Press.
- American Psychological Association. (2022). *Manual de Publicaciones de la APA*. Editorial El Manual Moderno.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlusopen*, 2, 8-14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>
- Blanco, A. y Díaz, D. (2005). El bienestar social: su concepto y medición. *Psicothema*, 17(4), 582-589. <https://www.redalyc.org/pdf/727/72717407.pdf>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. <https://sci-hub.se/10.1191/1478088706qp0630a>
- Chen C, Chen Y, Huang Q, Yan S, Zhu J. (2022). Self-Care Ability of Patients With Severe Mental Disorders: Based on Community Patients Investigation in Beijing, China. *Front Public Health*, 1;10:847098. doi: 10.3389/fpubh.2022.847098
- Creswell, J. (2007). *Qualitative inquiry & research design*. Sage Publications.
- Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C. y Dierendonck, D. (2006). *Psicothema*, 18(3), 572-577. <https://www.redalyc.org/pdf/727/72718337.pdf>
- Diez-Canseco, F., Rojas-Vargas, J., Toyama, M., Mendoza, M., Cavero, V., Maldonado, H., ... & Cutipé, Y. (2020). Estudio cualitativo sobre la implementación del Programa de continuidad de cuidados y rehabilitación para personas con trastornos mentales graves en el Perú. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 44.
- Enfermería en Desarrollo. (2019). Ocio terapéutico para promover la recuperación. *Enfermería en Desarrollo*(20), 32-39. Obtenido de https://enfermeriaendesarrollo.es/wp-content/uploads/2020/01/EnD_20_enero_2019.pdf
- Escuela de salud y cuidados de Castilla-La Mancha. (2022). *Memoria año 2022*. Castilla-La Mancha. Obtenido de https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/memoria_de_actividades_esacu_2022-2.pdf
- Fernández, A., García-Viniegras, C., & Ruiz, A. (2014). Consideraciones acerca del bienestar psicológico. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 17(3), 1108-1140. <https://psicologia.iztacala.unam.mx/rep/ wp-content/uploads/2018/11/11-vol-17-no-3-sept-2014.pdf>
- Godfrey, C., Harrison, M., Lysaght, R., Lamb, M., Graham, I. & Oakley, P. (2011). Care of self - care by other - care of other: the meaning of self-care from research, practice, policy and industry perspectives. *International Journal of Evidence-based Healthcare*, 9(1), 3-24. doi: 10.1111/j.1744-1609.2010.00196.x.

- Huenchuan, S. y Rodríguez, R. I. (eds.) (2014). *Autonomía y dignidad en la vejez: Teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores*. Ciudad de México: Naciones Unidas. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37523/S1421014_es.pdf;sequence=1
- Lam-Flores, S. A.-O.-C.-V. (2024). Desarrollo y validación de la escala de autocuidado de salud mental en adultos peruanos. *Población y Salud en Mesoamérica*, 2(21). doi:<https://doi.org/10.15517/psm.v21i2.56277>
- Lip Licham, C., y Rocabado Quevedo, F. (2005). *Determinantes sociales de la salud en Perú*. Organización Panamericana de la Salud. https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/143_detersoc.pdf
- López-Pérez, B., Fernández-Pinto, I. & Márquez-González, M. (2008). Educación emocional en adultos y personas mayores. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, 15,6(2), 501-522. <https://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/1286>
- Lune, H., & Berg, B. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas
- Megías, F. (2017). *Evolución de los cuidados a las personas con problemas de salud mental. Un análisis social desde la perspectiva enfermera*. Alcalá de Henares. Obtenido de <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/41210>
- Mejía, J. (2000). El muestreo en la investigación cualitativa. *Investigaciones Sociales*, 4(5), 165-180. Recuperado de: <http://www.acuedi.org/ddata/3754.pdf>
- Mertens, D. (2015). *Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods*. SAGE.
- Miles, M., Huberman, A. & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications
- Ministerio de Salud del Perú (2018). Carga de enfermedad en el Perú: estimación de los años de vida saludable perdidos 2016. Lima: MINSA <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/276778-carga-de-enfermedad-en-el-peru-estimacion-de-los-anos-de-vida-saludables-perdidos-2016>
- Ministerio de Salud del Perú (2023). Conocer los Centros de Salud Mental Comunitaria en el Perú. <https://www.gob.pe/10942-conocer-los-centros-de-salud-mental-comunitaria-en-el-peru> Consultado el 20 de marzo del 2023.
- Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa (2010). User empowerment in mental health - a statement by the WHO Regional Office for Europe. Disponible en: http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Declaracion_Empoderamiento_OMS.pdf
- Rai, S., Gurung, D., Kaiser, B. N., Sikkema, K. J., Dhakal, M., Bhardwaj, A., Tergesen, C., & Kohrt, B. A. (2018). A service user co-facilitated intervention to reduce mental illness stigma among primary healthcare workers: Utilizing perspectives of family members and caregivers. *Families, Systems, & Health*, 36(2), 198–209. <https://doi.org/10.1037/fsh0000338>
- Ryff, C. y Keyes, C. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719-727.

https://www.researchgate.net/publication/15726128_The_Structure_of_Psychological_Well-Being_Revisited

Salas Sánchez, A. L. (2016). *Agentes comunitarios de la salud y estrategias de autocuidado de la salud mental en un distrito de Chincha*. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP tesis. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/7475>

Üstün B, Gerçik E. (2023). Self-care Power and Healthy Lifestyle Behaviors in Persons with Severe Mental Illness. *Mediterranean Nurse Midwifery*, 3(3), 165-173. DOI:10.4274/MNM.2023.23152

World Health Organization (2021). *Atlas of Mental Health of the Americas 2020*. Ginebra, World Health Organization. <https://www.sjis.net/documentos/ficha/567706.pdf>

Setiembre, 2024